HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»

КОНСПЕКТ УРОКА

Вступительный урок

смешанный тип пищеварения

О чём этот урок

Вводный урок к **протоколу по смешанному типу пищеварения**. По результатам диагностического теста у вас определён смешанный тип. Разбираем, почему вам предложен именно этот протокол, в чём его особенности и что мы будем делать в ближайшие недели.

Смешанный тип — не официальный диагноз, а собирательный термин. Он описывает состояние пищеварительной системы и организма в целом, при котором сочетаются две разнонаправленные проблемы:

- **ЖКТ работает вяло**: моторные и секреторные функции желудка, поджелудочной, тонкой и толстой кишки снижены;
- **при этом есть хроническое воспаление** — в самом ЖКТ или рядом с ним (печень, желчевыводящие пути) либо системное.

1. Как проявляется смешанный тип

Признаки вялой работы ЖКТ

✔️ тяжесть после еды

✔️ слабые тупые (не острые) боли в правом подреберье

✔️ вздутие сразу после еды — в течение 30–60 минут, почти после каждого приёма пищи

✔️ метеоризм после любой еды и даже после прохладной воды и напитков

✔️ ощущение, что еда медленно переваривается и долго стоит в желудке

✔️ переполненность желудка после еды

✔️ слабый аппетит: может не хотеться есть до 11–12 часов, но вечером голод появляется

✔️ изжога после мучного, сладкого, крахмалистого (картофель, рис)

✔️ частая отрыжка

✔️ тошнота на жирную и/или белковую еду

✔️ запоры или диарея — зависит от работы желчеоттока, кишечника, ферментов

✔️ тонкий белый налёт, равномерно по всему языку

Чем больше жалоб, тем сильнее снижена активность ЖКТ.

Хроническое воспаление

Слабое, вяло текущее, редко себя проявляющее — но оно может быть. Где именно:

Локализация	Возможные диагнозы
В самом ЖКТ	Гастриты различных типов, ГЭРБ, дуоденит, хронический холецистит, хронический панкреатит, воспалительные заболевания кишечника (колит, язвенный колит, энтерит и т. д.), дисбиоз, СИБР, хеликобактерная инфекция
В печени и жёлчном пузыре	Хронический гепатит, стеатогепатит (жировой гепатоз + воспаление), синдром Жильбера
После удаления жёлчного пузыря	Слабое воспаление в тонкой кишке
Системное хроническое воспаление	Может сопровождаться аллергическими реакциями, артериальной гипертензией, аутоиммунными заболеваниями

Не факт, что у вас есть всё это, — скорее один-два диагноза.

2. Риски смешанного типа

Из-за вялой работы ЖКТ

✔️ дефициты белка, железа, B12, B9 и других витаминов и микроэлементов

✔️ дисбиоз кишечника

✔️ жёлчный сладж → желчнокаменная болезнь → удаление жёлчного пузыря

✔️ жировая болезнь печени

Из-за воспаления

✔️ дальнейшее развитие воспалительных заболеваний — в самом ЖКТ, в печени

✔️ или развитие системного хронического воспаления

Почему дефициты так важны: пищеварительная система — основное место усвоения питательных веществ. Если она работает хуже, формируются дефициты → страдает обмен веществ → клетки недополучают питание → падает энергия, снижается сопротивляемость болезням. Мы чувствуем себя хуже, быстрее стареем, у организма меньше ресурсов справляться с заболеваниями.

Смысл программы — сбалансировать два разнонаправленных состояния: не дать развиться воспалению, где бы оно ни было, и при этом поддержать работу пищеварения.

3. Какие обследования можно пройти

Для программы это **необязательный шаг**, но если хотите точно понимать, что с вами происходит, обследоваться разумно.

> **Важно:** точный список анализов для вашей ситуации назначает и интерпретирует **врач-гастроэнтеролог** — это сложная задача, нужен комплексный подход. Список ниже нужен, чтобы у вас была аргументированная позиция в разговоре с врачом: что сдать и зачем.

3.1. УЗИ органов брюшной полости

Базовый, простой, неинвазивный, быстрый анализ — хорош для старта. Оценивает:

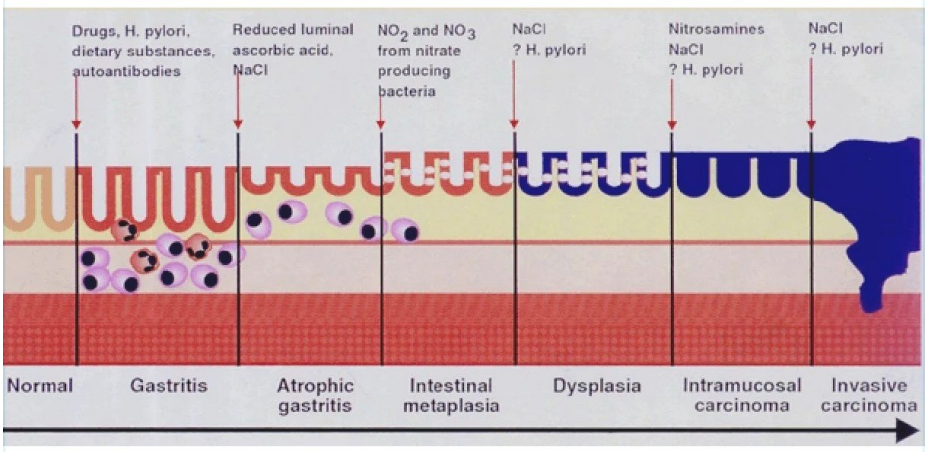
- **жёлчный пузырь:** толщина стенок (хроническое воспаление, перенесённый холецистит), полипы, сладж, камни, дискинезия, риски нарушения желчеоттока;
- **печень:** диффузные изменения (жировой гепатоз), кисты, гемангиомы;
- **поджелудочную:** структурные изменения, липоматоз (обрастание жиром).

3.2. Оценка функций желудка

Обследование	Что даёт
Кровь на «Гастропанель»: пепсиноген I и II, гастрин-17, антитела к H. pylori	Самый простой и неинвазивный вариант. Есть ли воспаление и атрофия слизистой, насколько эффективно работает желудок, кислотность (повышена, понижена, норма), активная или перенесённая инфекция H. pylori
ФГДС	Камера на конце трубки в реальном времени показывает пищевод, смыкание клапанов, слизистую желудка и 12-перстной кишки: структурные изменения, воспаление, эрозии, язвы. Биопсия в нескольких точках — оценка клеток слизистой и диагностика H. pylori. Сейчас делается под седацией
24-часовая pH-метрия	При изжоге и ГЭРБ: зонд на сутки измеряет кислотность, количество и тяжесть рефлюксов

Все три сдавать не нужно — обычно назначают один или два. Если к ФГДС есть противопоказания или человек отказывается, смотрят гастропанель.

Каскад Корреа — почему важно проверять желудок



Каскад Корреа: стадии развития заболеваний желудка

Особенность желудка: дела могут идти плохо, а **острых болей нет**. Есть тяжесть, «пища долго стоит», неприятно — но «раз не болит, проблем нет», и человек не идёт обследоваться. Так можно дойти до серьёзного диагноза: рак желудка входит в пятёрку самых распространённых онкологий ЖКТ и, как правило, обнаруживается поздно.

Стадия	Что происходит
Гастрит	Воспаление слизистой желудка; присоединяется H. pylori и ухудшает ситуацию
Атрофический гастрит	Слизистая сглаживается, клетки хуже выделяют пищеварительные соки; желудок вялый, атоничный, плохо выполняет моторную функцию
Кишечная метаплазия	В желудке появляются клетки, которых там быть не должно
Дисплазия → онкология	При неблагоприятном развитии

Рекомендация: в европейских и американских протоколах ФГДС после 45 лет рекомендована раз в 2–3 года при отсутствии жалоб, при жалобах — чаще. С определённого возраста стоит хотя бы раз проверить желудок, чтобы не пропустить серьёзное.

3.3. Анализы крови

Показатели	Что оценивают
АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий и прямой	Печень и желчевыводящие пути: застой желчи, воспаление
Общий белок, альбумин	Усвоение белка — строительного материала всех клеток
ОАК (гемоглобин, эритроциты, индексы), ферритин; B12 и фолиевая кислота — по желанию	Дефицит железа и его кофакторов. При заболеваниях ЖКТ, особенно атрофическом гастрите, усвоение железа и B12 страдает — за белком, железом и B12 нужно следить
СРБ ультрачувствительный, СОЭ	Общий уровень воспаления (также косвенно — ферритин, общий белок)

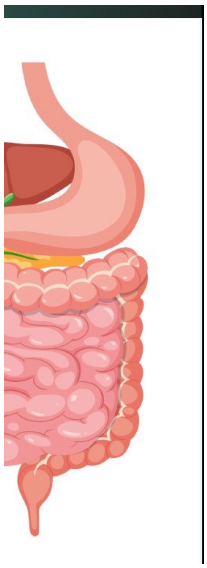
3.4. Анализы кала и дыхательный тест

Анализ	Что показывает
Кал на скрытую кровь и кальпротектин	Есть ли воспаление в кишечнике. Тонкую кишку аппаратно исследовать сложно — ни колоноскоп, ни ФГДС туда не достают. При отклонениях гастроэнтеролог может назначить колоноскопию
Кал на панкреатическую эластазу	Недорогой информативный анализ: насколько эффективно поджелудочная выделяет ферменты
Копрограмма	Совокупная оценка всех отделов ЖКТ. Быстро показывает, что что-то не так, но не где: мышечные волокна в стуле могут говорить и о проблемах желудка, и о нехватке ферментов поджелудочной. Удобна для отслеживания динамики при изменениях в питании и лечении
Водородно-дыхательный тест	При частом вздутии «на всё подряд», особенно на квашеные овощи, кимчи, комбучу, кисломолочное, шампанское, пробиотики — подозрение на СИБР. Также непереносимость лактозы, фруктозы, других сахаров

> **Первый правильный шаг**, если хотите дообследоваться, особенно при жалобах, — к гастроэнтерологу за стратегией обследования. Все анализы сдавать не обязательно.

4. Цель программы

Мягко усилить активность ЖКТ, но не поднять при этом воспаление.



- восстановить моторику ЖКТ и желчевыделение;
- улучшить переваривание пищи и всасывание питательных веществ — не уходить в дефициты;
- наладить нервную регуляцию работы ЖКТ;
- профилактировать дальнейшее развитие воспаления;
- повысить качество жизни и энергию.

Как мы будем работать

1. **Налаживание режима дня.**
2. **Регуляция нервной системы**, снижение хронического стресса.
3. **Коррекция питания**: убрать то, что мешает пищеварению при смешанном типе и поддерживает воспаление; добавить продукты — мягкие стимуляторы ЖКТ.
4. **Полноценное меню из легкоусвояемых блюд**, закрывающее фоновые дефициты.
5. **Специи и травы** — часть уже есть в уроках текущей недели.
6. **Домашние процедуры.**

Вопросы для самопроверки

1. Что такое смешанный тип пищеварения? Какие две разнонаправленные проблемы в нём сочетаются?
2. Какие признаки говорят о вялой работе ЖКТ?
3. Как может вести себя аппетит при смешанном типе?
4. Какая изжога характерна для смешанного типа?
5. Где может локализоваться хроническое воспаление при смешанном типе? Приведите примеры диагнозов.

6. Какие риски связаны с вялой работой ЖКТ? Почему развиваются дефициты и к чему они ведут?
7. Какие риски связаны с воспалением?
8. В чём главный смысл программы при смешанном типе?
9. Кто назначает и интерпретирует анализы и зачем знать их список?
10. Что можно оценить с помощью УЗИ органов брюшной полости?
11. Какие обследования помогают оценить желудок и чем они отличаются?
12. Опишите стадии каскада Корреа. Почему болезни желудка часто обнаруживают поздно?
13. Как часто рекомендуется делать ФГДС после 45 лет?
14. Какие анализы крови оценивают печень, усвоение белка, дефицит железа и воспаление?
15. Почему кальпротектин важен для оценки тонкой кишки?
16. Чем полезна копрограмма и в чём её ограничение?
17. Когда стоит сделать водородно-дыхательный тест?
18. Какова цель программы при смешанном типе и через какие методы мы будем работать?